

耻骨上膀胱造瘘管置入术

患者须知 · 了解您的手术

WARWIKI

耻骨上膀胱造瘘管（suprapubic catheter，简称SPT或SPC）是一根软管，从下腹部耻骨上方的小切口直接引入膀胱排尿，无需经过尿道。本须知介绍置管原因、术前准备及术后注意事项。

关于这项操作

膀胱负责储存尿液。当尿液无法正常排出，或尿道需要休息及保护时，可在下腹部直接向膀胱置入导尿管。由于绕过了尿道，耻骨上膀胱造瘘管长期使用更为舒适，对尿道的刺激也更小。

您的医疗团队可能因以下原因建议置管：

- 自行排尿困难，需引流膀胱
- 手术或损伤后需保护尿道
- 需要舒适的长期引流（如神经源性膀胱）
- 避免长期经尿道导尿引起的刺激
- 保持正常性生活；可夹管进行"排尿试验"

安全吗？

是的，这是一项常见、总体安全的操作。术中需充盈膀胱使其贴近腹壁，团队通常借助超声和（或）膀胱镜引导，以避免损伤肠道。多数不适（少量出血、轻度疼痛或膀胱痉挛）较轻微，很快缓解。若您曾做过腹部或盆腔手术，请提前告知团队。

名词解释

耻骨上（Suprapubic）

耻骨上方、下腹部位置——造瘘管从此处穿出。

膀胱

储存尿液的器官，排尿时将尿液排出体外。

导尿管（Catheter）

引流尿液的软管。耻骨上膀胱造瘘管经腹壁而非尿道引流。

尿道（Urethra）

正常将尿液排出体外的管道。耻骨上膀胱造瘘管绕过尿道。

局部麻醉

在皮肤局部注射麻药，使该区域无痛感。

镇静／麻醉

使您放松或入睡的药物（局麻加镇静，或全身麻醉）。

超声／膀胱镜

引导置管的工具（超声波成像，或膀胱内小型摄像头）。

膀胱痉挛

膀胱突然抽搐感——术后常见，可以治疗。

会疼吗？ 取决于麻醉方式：部分操作采用局部麻醉加镇静；也有许多在**全身麻醉或脊椎麻醉**下进行，届时您处于睡眠或下半身麻木状态。您的团队会提前告知。术后可能有轻度酸痛或膀胱痉挛，属正常现象。操作约需15–30分钟。

如何准备（术前）

- **如有要求，请憋尿来院** — 膀胱充盈可使置管更安全。团队也可能让您提前饮水，或在操作开始时向膀胱注水。
- **遵守禁食禁水要求** — 若需镇静或全身麻醉，通常需在操作前数小时禁食禁水。
- **安排他人接送**（如需镇静）。

请提前告知您的团队以下情况：

- 曾接受**腹部或盆腔手术** — 瘢痕组织可能改变最佳置管路径
- 正在服用**抗凝药**或有出血问题 — 通常需在术前暂停
- 可能**怀孕**，或有感染、麻醉药或乳胶过敏史

操作过程

- 1 摆好体位后给予麻醉——局麻加镇静，或全身麻醉/脊椎麻醉。下腹部皮肤消毒铺巾。
- 2 若膀胱尚未充盈，向其注入液体，使其紧贴腹壁、远离肠道。
- 3 在超声和（或）膀胱镜引导下，于耻骨上方做一小切口，将导尿管送入膀胱。
- 4 导尿管末端在膀胱内充盈气囊以固定，另一端连接引流袋。

之后

- 尿液引流至引流袋。出院前团队将**指导您如何护理导管及周围皮肤**。
- 术后一两天内轻微酸痛、膀胱痉挛或**尿液中少量血丝**均属正常。
- **首次更换导管由团队完成**，约在置管后4–6周。若导管脱出，请立即联系团队——造瘘口可在数小时内闭合。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- 导管**脱出**或停止引流（引流袋无尿液）
- 腹痛加重、肿胀或大量出血
- 尿液浑浊、有异味（感染迹象）

需要记住的三件事

1. 耻骨上膀胱造瘘管经下腹部小切口引流膀胱，绕过尿道，长期引流更为舒适。
2. 术前准备：如需要请憋尿来院，遵守禁食禁水要求，如需镇静请安排接送，并提前告知腹部手术史、抗凝药使用情况或可能怀孕。
3. 操作在麻醉下进行（局麻加镇静或全身麻醉）。团队将指导导管护理，并在约4–6周后进行首次更换。导管脱出、发热或无尿引流时请立即就医。